要介護認定調査票・ペルソナ症例 02

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	田中 健一（たなか けんいち）	**年齢 / 性別**	78歳 / 男性
要介護度	要介護2	**調査実施者**	地域包括支援センター職員（社会福祉士）

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】通所介護（デイサービス）週3回、訪問リハビリテーション週1回、福祉用具貸与（歩行器）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】妻（76歳・主介護者）と二人暮らし。娘夫婦は近隣（車で15分）に居住。
【居住環境】バリアフリー改修済みのマンション住まい。
【主な介護者】妻（主介護者）。
【傷病・既往歴】脳梗塞後遺症（右不全麻痺）、高血圧症、糖尿病。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	脳梗塞後遺症（右不全麻痺）、高血圧症、2型糖尿病
傷病の経過・治療内容	数年前に脳梗塞を発症し右不全麻痺が残存。近年は高次脳機能障害（注意障害・意欲低下）の傾向がみられ、服薬や金銭管理にミスが生じやすい。
医学的管理の必要性	抗血小板薬、降圧薬、血糖降下薬の内服指導。SMBG（血糖自己測定）の実施と血圧・血糖値の定期チェック。
身体障害に関する意見	右上下肢に軽度麻痺（巧緻運動障害含む）あり。歩行器使用にて屋内移動は安定するが、屋外移動は不安定で介助が必要。
精神・認知機能の意見	軽度認知障害（MCI）および注意障害。短期記憶の低下があり、物盗られ妄想的な発言（一過性）がみられる。
特別医療・ケアの必要性	インスリン注射や自己血糖測定の手技自体は可能だが、認知機能低下による誤薬・過量服薬のリスクがあり、家族または看護師による服薬管理が必須。
介護に関する医学的意見	医学的管理の継続と同時に、服薬管理・金銭管理の支援体制が不可欠。主介護者である妻の精神的・身体的負担（介護疲れ）が大きいため、レスパイトケアを組み入れたケアプランが強く推奨される。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：右軽度麻痺あり (2)
2. 麻痺（下肢）：右軽度麻痺あり（引きずり傾向） (2)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：なし (1)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：自立 (1)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：自立（やや右重心の偏りあり） (1)
9. 歩行：歩行器使用にて安定 (2)
10. 立ち上がり：手すりを使用して自立 (1)
11. 片足立ち：困難 (3)
12. 洗顔：一部介助（右手の巧緻性低下のため左手中心） (2)
13. 爪切り：全介助（右麻痺と視力低下のため妻が実施） (4)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：自立 (1)
2. 移動（屋内）：歩行器利用にて自立 (1)
3. 移動（屋外）：一部介助（車椅子利用または妻の付き添い） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立（衣服の上げ下ろしに一部妻の補助あり） (2)
6. 排泄（排便コントロール）：自立 (1)
7. 衣服着脱（上衣）：一部介助 (2)
8. 衣服着脱（ズボン等）：一部介助 (2)
9. 入浴：一部介助（浴槽への出入り、洗身、洗髪に全面的に見守りと一部介助） (2)
10. 口腔清潔：自立 (1)
11. 洗髪：全介助（妻またはデイサービスで実施） (4)
12. 買い物：できない (4)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶：軽度の低下あり (2)
4. 日付の理解：今日の日付がすぐに出ないことがある (2)
5. 場所の理解：わかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：わかる (1)
9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：軽度あり (2)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：軽度あり (2)
7. 羞恥心の喪失：なし (1)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：軽度あり（「財布や通帳を誰かに取られた」と一時的に疑う） (2)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：全介助（妻が厳重に管理・配薬） (4)
2. 金銭管理：できない（妻が管理） (4)
3. 簡単な調理：できない (4)
4. 電話の利用：一部介助（受話のみ可能） (2)
5. 社会的交流：一部介助（デイサービスには通うが交流は減少） (2)
6. 日常の意思決定：一部介助 (2)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

右不全麻痺と軽度の高次脳機能障害があり、服薬管理や金銭管理に妻の全介助を要する。性格の頑なさから妻へのフラストレーションが強く、被害妄想的発言（物盗られ妄想の萌芽）が見られる。主介護者である妻の介護疲れが蓄積しており、デイサービス（週3回）やショートステイの活用が必須。